



КНП «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»
вул. Верховинна, 69, м. Київ, 03115, тел. (044) 4239607
E-mail: petctkyiv@gmail.com
Код ЄДРПОУ 13697965

Протокол поєднаного ПЕТ-КТ дослідження

Пацієнт (П.І.Б.): *Жерліцина Анастасія Станіславівна*

Дата народження: 25.04.1976р.

№ медичної карти: 13189/26

Вага пацієнта: 65 кг.

Дата проведення дослідження: 23.09.2026р.

Апарат на якому проводилось дослідження: ПЕТ-КТ GE Discovery STE16

РФП: 18 F-FDG

Активність РФП: 260 МБк

Шлях введення РФП: в/венно

Ефективна доза low-dose КТ: 5.64 мЗв

Ефективна доза ПЕТ: 4.94 мЗв

Сумарна доза ПЕТ/КТ: 10.58 мЗв

Підготовка: дослідження проведено натще, пероральне водне навантаження.

Дослідження проведено на 80 хв. після ін'єкції РФП

Область обстеження: від надбрівних дуг до с/3 стегна

Показник цукру на момент обстеження: 5.9 ммоль/л

Діагноз: Лейоміосаркома тіла матки, T2NxM1. Вторинне ураження печінки, брюшини. Прогресія хвороби в печінці.

GIST шлунку

Anamnesis morbi:

ПГЗ(печінки) 2023р.- метастаз лейоміосаркома матки; ПГЗ(шлунку) від 2023р. - GIST шлунку, метастаз GIST в печінку;

Оперативне лікування – 01.2023р.- повторна біопсія печінки; 11.04.2023р. – біопсія шлунку, core – біопсія печінки;

Хіміотерапія – 4 курси у 2022р. + курси лікування ТТ – Пазопанібом, надалі - 3,5 роки Іматінібом

Описання знімків ПЕТ-КТ дослідження(порівняння з ПЕТ/КТ від 19.0

Шия: візуалізується симетрична фіксація препарату в мигдаликах, що є фізіологічним процесом.

Інших ділянок з фіксацією препарату в органах ший не виявлено.

Лімфовузлів ший, над-, підключичних та аксілярних груп з патологічним накопиченням РФП не візуалізується.

Грудна клітка: в паренхімі правої, лівої легень та органах середостіння без патологічного гіперметаболізму.

В середній - нижній/3 стравоходу візуалізується підвищена фіксація РФП середньої – високої інтенсивності $SUV_{max} = 2,0-3,2$, без додаткових об'ємних утворень.

В молочних залозах візуалізується фізіологічний розподіл препарату.

В міокарді візуалізується фізіологічний розподіл РФП. Медіастінальний пул $SUV_{max} = 1,6$.

Лімфовузлів середостіння та коренів легень з патологічним накопиченням РФП не виявлено.

Черевна порожнина: в стінках шлунку візуалізується відносно рівномірний розподіл РФП $SUV_{max} =$ до 2,8, без підозрілих вогнищ гіперметаболізму. По малій кривизні зберігається FDG- негативне утворення, щільно до хвоста підшлункової залози, з ознаками звапнення, розміром 43х32мм(раніше - 4,3х3,3см).

В печінці зберігаються раніше відомі множинні аметаболічні утвори(найбільший розміром 98х148мм в правій частці - раніше 14,4х10,4мм) з проростом метаболічної активності по контуру та в структурі деяких, високої інтенсивності $SUV_{max} =$ до 4,9, метаболічним розміром в лівій частці до 35х54мм(зливного характеру) та до 15х24мм в структурі аметаболічної ділянки в S8.

В селезінці, підшлунковій залозі та обох наднирниках візуалізується фізіологічний розподіл РФП.

Стінки тонкої та товстої кишок без патологічного гіперметаболізму.

Фіксація РФП в обох нирках є фізіологічною для даного РФП.

Лімфовузлів черевної порожнини та заочеревинного простору з патологічним накопиченням РФП не виявлено.

Малий таз: стан після хіміотерапевтичного лікування з приводу лейоміосаркоми тіла матки. По передній стінці матки зберігається неоднорідний утвір $SUV_{max} =$ до 1,8, з наявними кальцинатами в структурі, розміром 67х49мм(раніше – 6,8х5,5см).

Зберігається стабільне аметаболічне вузлове утворення по верхньому ребру, розміром 37х47мм(4,6х3,7см).

Інших ділянок з патологічним накопиченням РФП в органах малого тазу не виявлено.

Відмічається фізіологічна фіксація препарату в сечовому міхурі.

Гіперметаболізму РФП в лімфовузлах малої миски, клубових та пахових груп не виявлено.

Скелет: в кістках патологічного метаболізму препарату, що вказує на остеолітичне ураження не виявлено.

лено.
гінним
Від 19.06
зах. що є фіз.

Заключення: ПЕТ/КТ-ознаки приросту метаболічної активності в множинних вогнищах ураження паренхіми печінки в порівнянні з ПЕТ/КТ від 19.06.2026р., що характерно для прогресії основного захворювання.

Стабільне низькоінтенсивне утворення тіла матки та стабільний аметаболічний вузол тіла матки без вираженої динаміки.

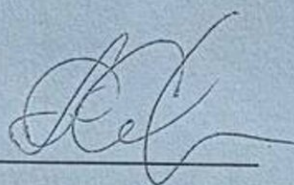
Зберігається стабільне FDG- негативне утворення тіла шлунку.

Фіксація РФП в стравоході може відповідати запальному генезу, проте, рекомендовано дообстеження – ЕГДС.

Інших даних за FDG- позитивний патологічний процес не виявлено.

Рекомендовано: консультація онколога; ПЕТ/КТ контроль лікування.

Лікар ядерної медицини Холодна А.В.



Увага! 18F-FDG не є специфічним радіофармпрепаратом. Неможливо виключити наявність FDG-нечутливого типу пухлин. Дане закінчення не може бути достовірним діагнозом. Достовірність даних ПЕТ/КТ вважати протягом трьох тижнів.